이어지는 진료, 세 사람의 안심

환자·보호자의 일상을 의료진의 질문에 연결하는 AI 소통 솔루션

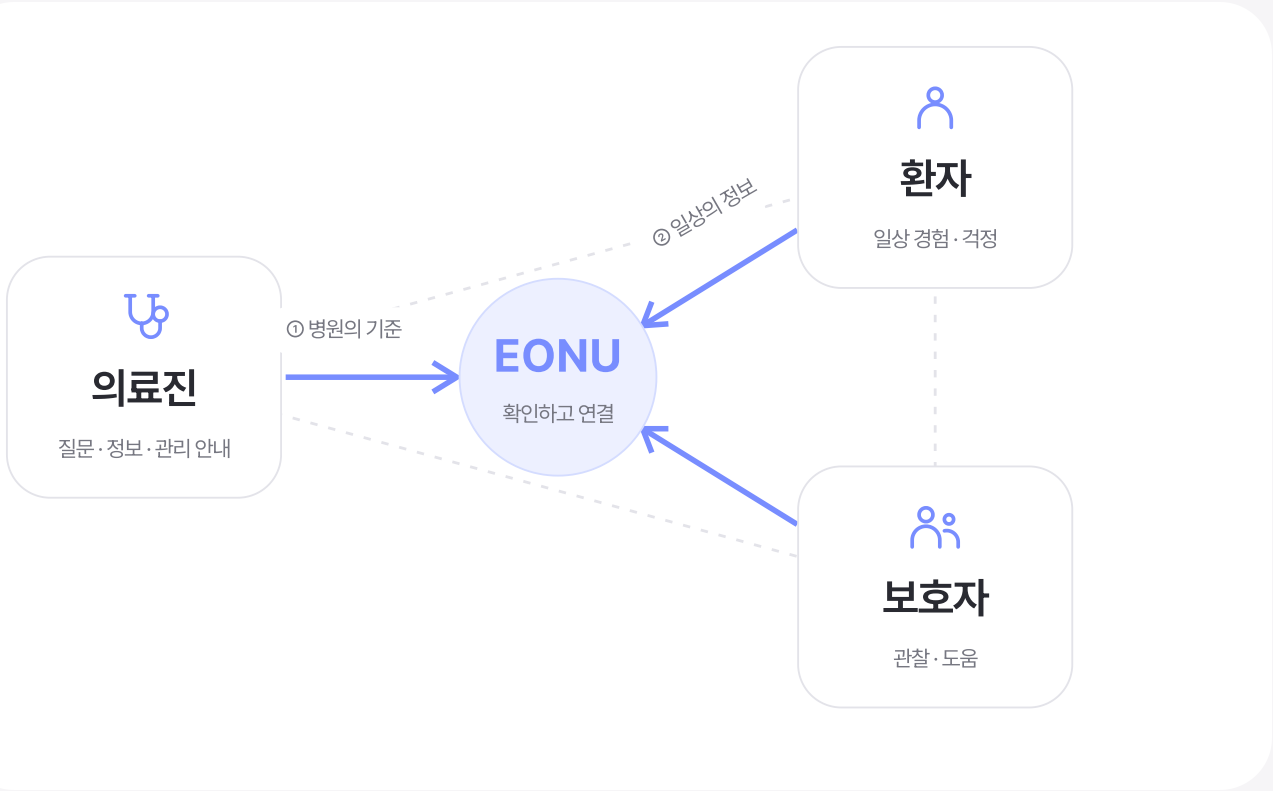
CARE THAT CONTINUES

EONU

일상의 이야기를 진료로,
진료의 계획을 일상으로.

환자와 보호자가 원하는 연결에
의료진이 지속해서 참여할 이유를 더합니다.

병원 중심 설계 | 환자·보호자 참여 | 전달 전 직접 확인



혼자 병원에 와도, 필요한 이야기는 함께 와야 합니다

동행하지 못한 보호자의 관찰과 환자의 경험이 진료실까지 이어지지 않는 순간

01



“언제부터 그랬나요?”

아이는 정확한 시점과 변화를
설명하기 어렵습니다.

02



“전하고 싶은 게 있는데”

보호자는 관찰을 알고 있지만
지금 곁에 있을 수 없습니다.

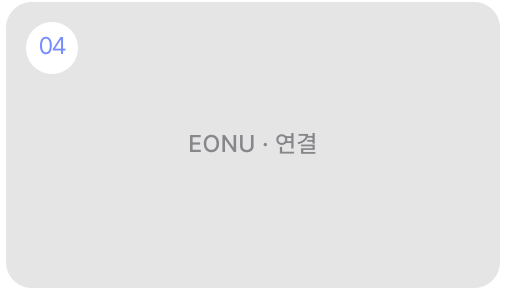
03



“확인할 정보가 필요해요”

의료진은 제한된 시간 안에
필요한 내용을 파악해야 합니다.

04



“함께 남긴 내용을 확인”

환자·보호자가 전달을 선택한
정보를 한 흐름으로 봅니다.

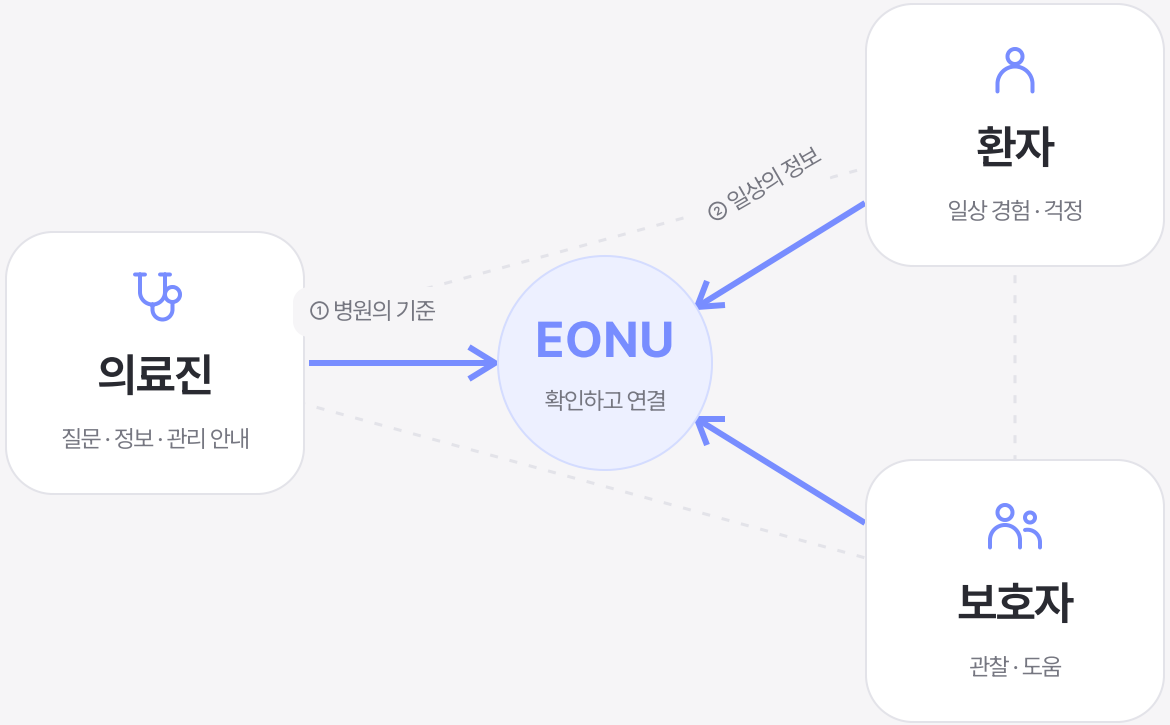
우리가 푸는 문제는 동행의 부재가 만든 **정보 전달의 공백**입니다.

보조 맥락 **보호자 없는 소아 진료에 관한 보도** — 본 사례의 실제 인물·발언을 뜻하지 않음

재구성한 설명용 사례. TV조선 2023.07.26 보도는 단독 내원 논란의 맥락 자료이며, 소통 공백의 빈도·증가를 입증하지 않습니다.

서로 다른 필요를 하나의 소통 흐름으로

환자의 경험, 보호자의 관찰, 의료진의 질문과 안내를 역할에 맞게 연결합니다.



환자 · 내 상황을 알아주길

일상 경험과 걱정을 필요한 내용으로 전달

보호자 · 전달하고, 돕고 싶음

관찰을 공유하고 진료 후 도울 일을 확인

의료진 · 빠르게 파악하고 싶음

병원이 요청한 정보와 원문을 함께 확인

확인된 계획이 다시 일상으로

제품이 지향하는 가치와 연결 구조. 임상 효과·업무 시간 절감이 검증되었다는 의미는 아닙니다.

환자의 걱정이 병원의 상담 기회로 이어진다면?

병원 도입을 설명하는 세 가지 가치 중, 초기에는 수익 기여 가능성을 검증합니다.

진료 효율
확인·입력의 전체 부담 측정

임상적 유용성
의료진의 실제 활용 여부 확인

수익 기여
초기 검증 초점 · 비급여 상담

기존 접점

홈페이지 · SNS · 광고

병원의 정보를 알리고
환자가 직접 탐색합니다.

기존 채널과 병행

EONU가 검증할 연결

미해결 걱정
일상 기록과 질문으로
관심·궁금증 구체화

→

관련 정보
병원이 설정한
서비스 안내 확인

→

자발적 상담
환자가 상담을 선택
의료진이 필요성 판단

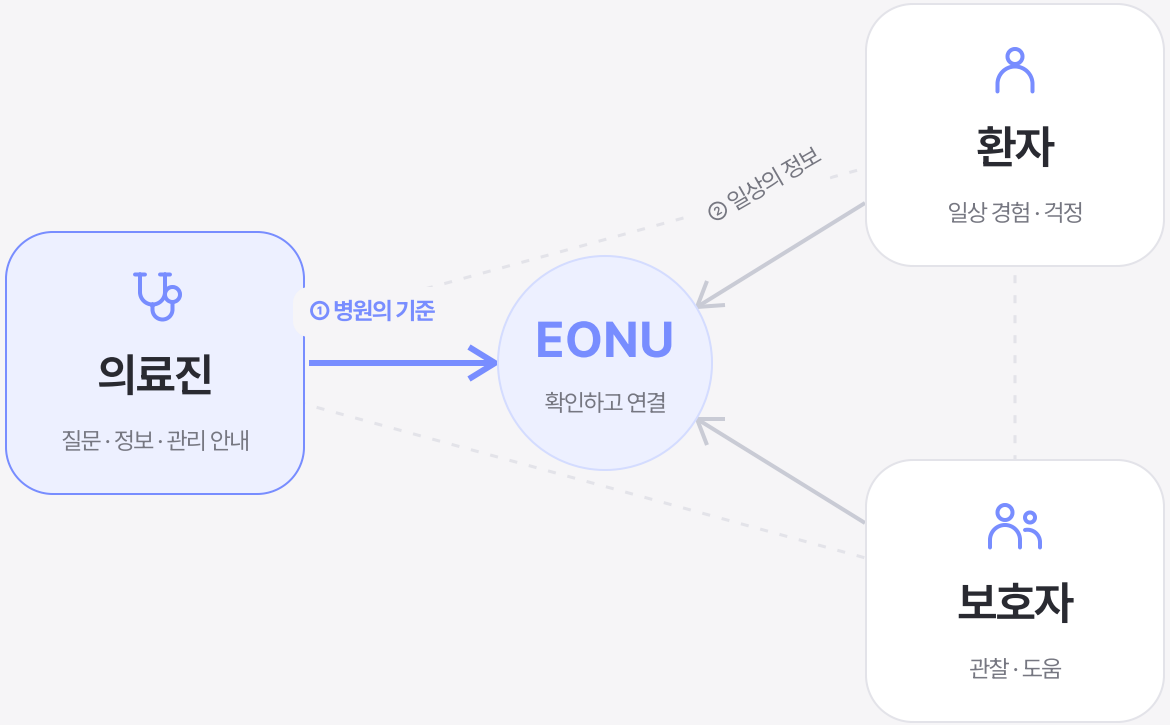
측정: 정보 확인 → 상담 요청 → 유료 도입 의사 · 업무 부담 함께 확인

비교 관점 기존 광고·환자관리와의 차별화 후보: **병원 질문 + 가족 관찰 + 전달 전 확인**

검증할 사업 가설. 개별 비급여의 필요성·상담 전환 성과는 미입증. 정보 제공·상담 연결 방식은 법적 검토 범위를 확인해야 합니다.

병원의 기준으로 시작하는 소통

① 의료진 → EONU: 먼저 확인할 질문, 서비스 정보, 진료 후 안내를 설정합니다.



의료진의 질문이 일상 기록의 기준이 됩니다.

병원 설정

초기 도입 흐름

1 **확인할 질문**
진료 전후 확인이 필요한 항목 설정

2 **서비스 정보**
급여·비급여 안내 범위와 설명 확인

3 **관리 안내**
진료 후 할 일과 보호자가 도울 내용

병원 안내 QR → 연결 화면에서 시작

설명용 제품 구조. 병원 안내 QR은 진입 방식이며, 이 자료에는 실제 접속용 QR을 넣지 않았습니다.

편하게 기록하고, 전달할 내용은 직접 확인합니다

병원 설정 → 환자·보호자 기록 → 전달 전 확인 → 의료진 확인

1 의료진 세팅

이번 진료에서 확인할 항목

- 일상에서 불편했던 순간
- 변화가 시작된 시점
- 진료 후 실천할 관리 계획

병원 안내

- 관련 서비스 정보

환자·보호자에게 안내

2 일상 기록

달력에서 할 일 확인

월	화	수	목	금	토	일
12	13	14	15	16	17	18

✓ 오늘의 관리 계획 확인

일기 · 음성 · 체크로 기록

환자 기록 | 보호자 관찰

작성자와 시점을 각각 보존

AI가 전달 요약 초안 정리

3 공유 전 직접 확인

원문 ↔ 요약 비교

원문 "저녁에 더 불편했어요."

요약 저녁 불편감 보고

시작 시점: 미확인

이 항목 공유 [on]

공유 대상 담당 병원

공유 항목과 범위는 당사자가 조정

확인 후 전달

4 의료진 확인

요청 항목별 전달 내용

- 요약 + 연결된 원문 보기
- 환자 / 보호자 작성 구분
- 미확인 항목 추가 질문

의료진 확인 상태 구분

기존 EMR 옆 별도 화면을 가정

진료 후 안내 → 일상으로

원문 · 작성자 · 시점 · 확인 상태를 남기고, 공유 범위를 직접 조정합니다.

실제 서비스 캡처가 아닌 설명용 UI 도식·가상 데이터. 구현 완료나 안전성 검증, EMR 연동 완료를 의미하지 않습니다.

병원에서 시작하고, 공공 영역도 검증합니다

초기 B2B 라이선스 → 유료 도입 검증 → B2B2C 확장 · B2G는 별도 구매 경로

FIRST CUSTOMER

B2B 라이선스

구매자: 일차의료기관
기관 단위 반복 이용료 가설

AFTER VALIDATION

B2B2C

환자·보호자의 추가 유료 가치
병원 도입 이후 별도 검증

B2G

소통 지원이 필요한 현장 → 구매기관·예산·조달 경로 확인
민간시설 인터뷰·의료봉사는 실증 접점으로 구분

첫 고객군 선정: 반복되는 소통 문제 × 도입 가치 × 실증 협조 가능성

유료 계약까지의 검증 단계

01 **가상 사례 검토**
의료진이 쓸 만한 정보인지 확인

02 **범위·기간을 정한 제한 실증**
활용·전체 부담·재사용 관찰

03 **유료 제안 → 계약**
가격 수용성과 구매 절차 확인

동의·권한·의료진 확인 절차
단계마다 운영 조건을 함께 검토

첫 병원군·가격·계약 상태 미확정. B2G는 공공 구매 계약을 의미하며, 연구지원금·민간 봉사활동과 구분합니다.

현재 판매할 상품으로 시장을 계산합니다

소프트웨어 매출 기준 · 시장의 상한과 일정 기간 내 실제 확보 목표를 분리

TAM 적용 가능한 전체 소프트웨어 시장

동일 상품을 판매할 수 있는 확장 범위

SAM 초기 집중시장

대상·업무·구매 조건에 맞는 기관

SOM 기간 내 확보 목표

[기간] 내 유료 [기관 수] × 연간 [가격]

현재 단계: 대상 정의 → 기관 수 확인 → 가격 검증 → 산정

입력값 확정 전

B2B · 기관 라이선스

대상 기관 [ ]곳 × 연간 가격 [ ]원

초기 시장 상한과 실제 유료 고객 목표를 구분

B2B2C · 추가 유료 서비스

연결 이용자 × 유료 전환율 × 연간 이용액

기관 계약에 포함된 요금과 중복 합산하지 않음

B2G · 별도 구매 계약

구매사업 [ ]건 × 계약 단가 [ ]원

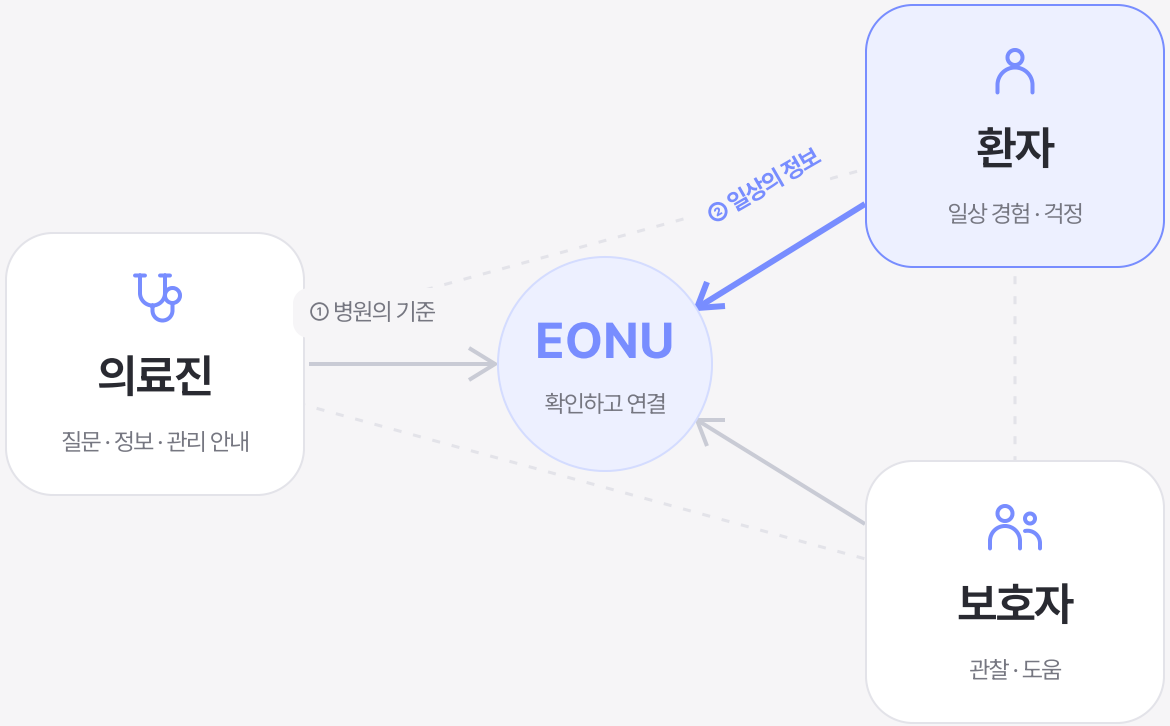
동일 공급 계약·연구지원금·미래 기기 매출 제외

가격 검증: 제공 원가 + 운영 비용을 확인하고 업무 가치·지불 의사로 검증

원문의 시장 입력값은 미확정. 포함 관계를 나타낸 개념도이며 도형 면적은 시장 금액·비율에 비례하지 않습니다.

쌓이는 일상 정보를 진료에 활용하도록

② 환자 → EONU: 병원 도입 검증 이후, 정보의 임상적 유용성과 수집 부담을 확인합니다.



환자 정보의 의미와 입력 부담을 함께 검증합니다.

01 · 초기 소프트웨어

일상 기록의 활용 가치

실제 진료 활용 · 기록 지속성 · 입력 부담

02 · 연결 확장

EMR · 외부 건강 앱

병렬 화면과 시스템 연동을 구분
권한·표준·연동 비용 확인 후 추진

03 · 추가 연구

기기 · 디지털 바이오마커

ADHD·노년층 등 대상별 수집 접근성
임상적 의미와 개발·운영 비용 검토

확장 방향·연구 과제. EMR·외부 앱·기기 연동 및 디지털 바이오마커는 구현·임상 검증 완료를 의미하지 않습니다.

현장에서 쓰이는 연결 방식을 축적합니다

진행 상태를 구분하고, 다음 검증에서 실제 활용·업무 부담·지불 의사를 확인합니다.

확인 항목	원문에 기재된 내용	자료 상태
MVP	구현 범위·사용 가능 기능 [확인 필요]	미확정
전문의 피드백	정신과 전문의의 지속 피드백 언급	범위 확인
기관 접점	의료혁신 연구소 관련 접점 언급	상태 확인
봉사 프로젝트	청년 우울증·자선사업 참여 확정 기재	원문 기재
실증 · 유료 계약	기관 수·기간·계약 증빙 [확인 필요]	미확정
법적 검토	검토 범위·의견·완료일 [확인 필요]	미확정

다음 검증에서 볼 것

01 **실제 활용**
의료진 확인율 · 정보 수정·누락

02 **전체 업무 부담**
환자 입력 + 의료진 확인·후속 업무

03 **반복 사용과 구매**
재사용률 · 유료 제안 응답 · 계약

축적 자산: 질문 · 템플릿 · 운영 경험

2026.10.20 MD 기재 기준. 기관·전문의 관련 언급은 자문·협의 범위 확인 필요. 계약·실증 실적 또는 공식 제휴로 표시하지 않았습니다.

1억 원으로 첫 유료 모델을 검증하겠습니다

직접 기획·개발하는 실행력을 바탕으로, 제품과 실증·고객 확보를 연결합니다.

대표 사진

기획 → 개발 → 수정

대표 중심의 실행

직접 수행

의료·AI 이해를 바탕으로
현장 질문을 제품으로 구현하고
피드백을 반영

필요한 협력

의료진의 임상 확인
개인정보·보안 및 실증 운영

고객 확보 경로

의료진·기관 소개 → 직접 접촉
방문 데모 → 제한 파일럿 → 유료 제안

USE OF FUNDS

배분 확정 전

1억 원

제품 개발·개선	[ ]만 원
개인정보·보안 검토	[ ]만 원
실증 설계·운영	[ ]만 원
고객 확보·방문 데모	[ ]만 원
API·클라우드·운영	[ ]만 원

항목별 금액의 합 = 10,000만 원
서비스 제공 원가와 고객 획득 비용은 분리 산정

자금이 만들 검증 결과

[ ]개월
집행 기간 · 월별 소진 계획

실증 [ ]곳
활용·부담·반복 사용 확인

유료 고객 [ ]곳
가격 수용성 · 구매 과정 확인

CAC = 고객 확보 비용 ÷ 신규 유료 기관 수
목표와 비용 확정 후 계산

1억 원은 MD의 사용계획 총액. 항목별 배분·집행 기간·실증 및 유료 고객 목표·CAC는 미확정이며 [ ]로 유지했습니다.

환자·보호자가 원하는 연결, 의료진도 지속할 이유

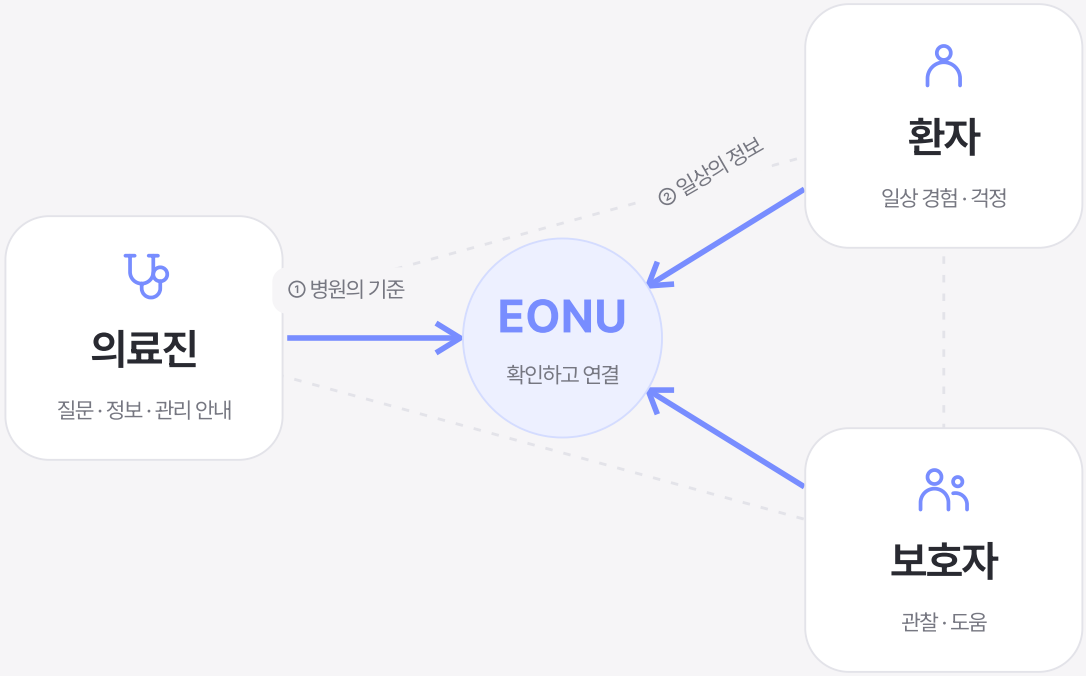
일상의 이야기를 진료로, 진료의 계획을 일상으로.

세 사람의 안심을
지속 가능한 연결로.

병원의 기준에서 시작해,
현장에서 쓰이고 지불할 가치가 있는지
차근차근 검증하겠습니다.

함께 확인할 다음 단계

첫 병원군 선정 · 제한 실증 · 유료 도입 검증



EONU / 이어온유 · 연락처 [확인 후 입력]